



Mobilização Articular

Capítulo 06 – Kisner e
Colby

Capítulo 04 – Bandy e
Sanders

Jogo Articular

- Excesso articular → Folga Articular (Jogo Articular);
- JA: Pré-requisito à ADM ativa normal → Pré requisito ao exercício terapêutico normal;
- Melhoria do JA através de procedimentos de Terapia Manual (Mobilização Passiva no sentido Transversal).

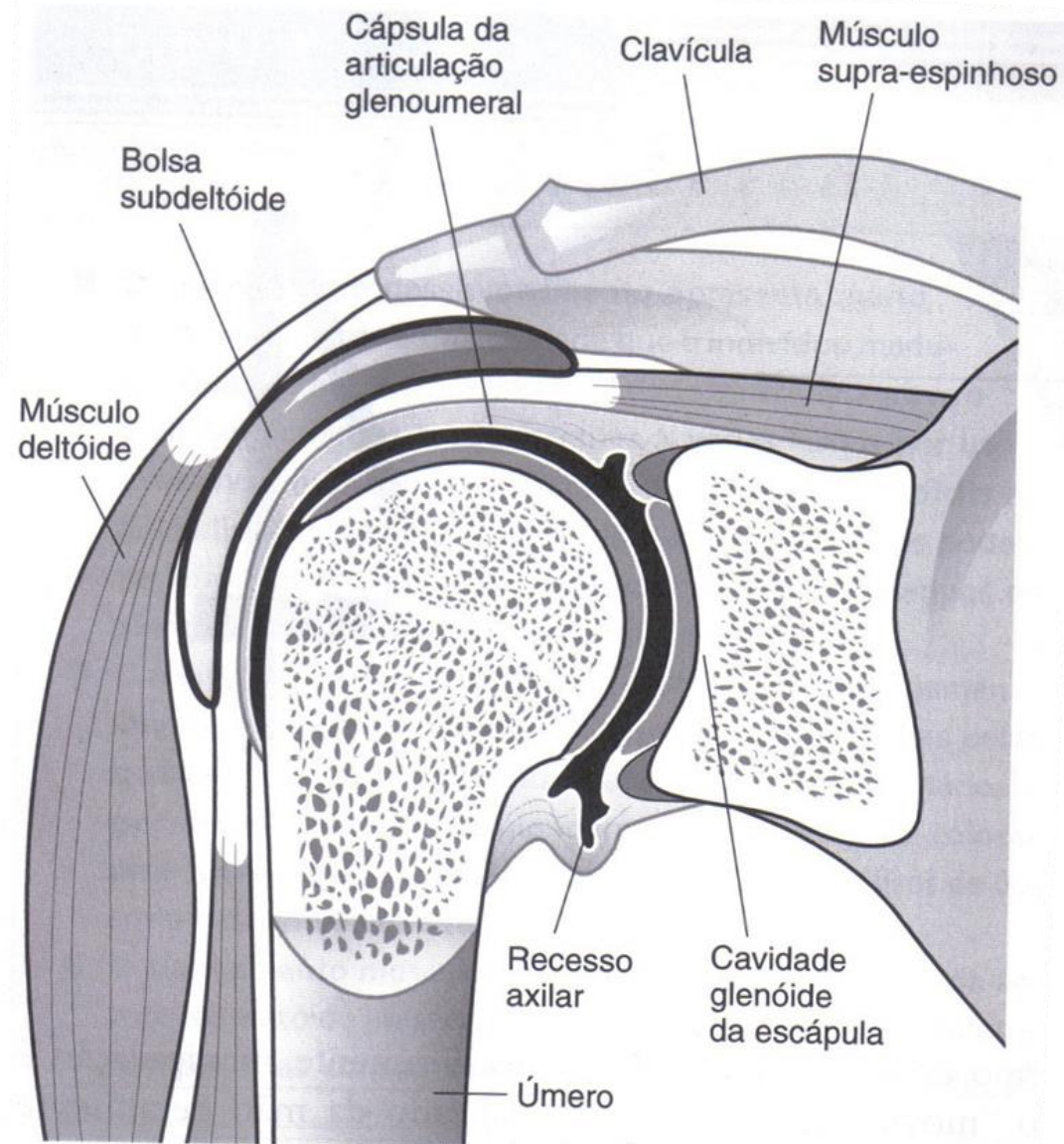


Fig. 4.1

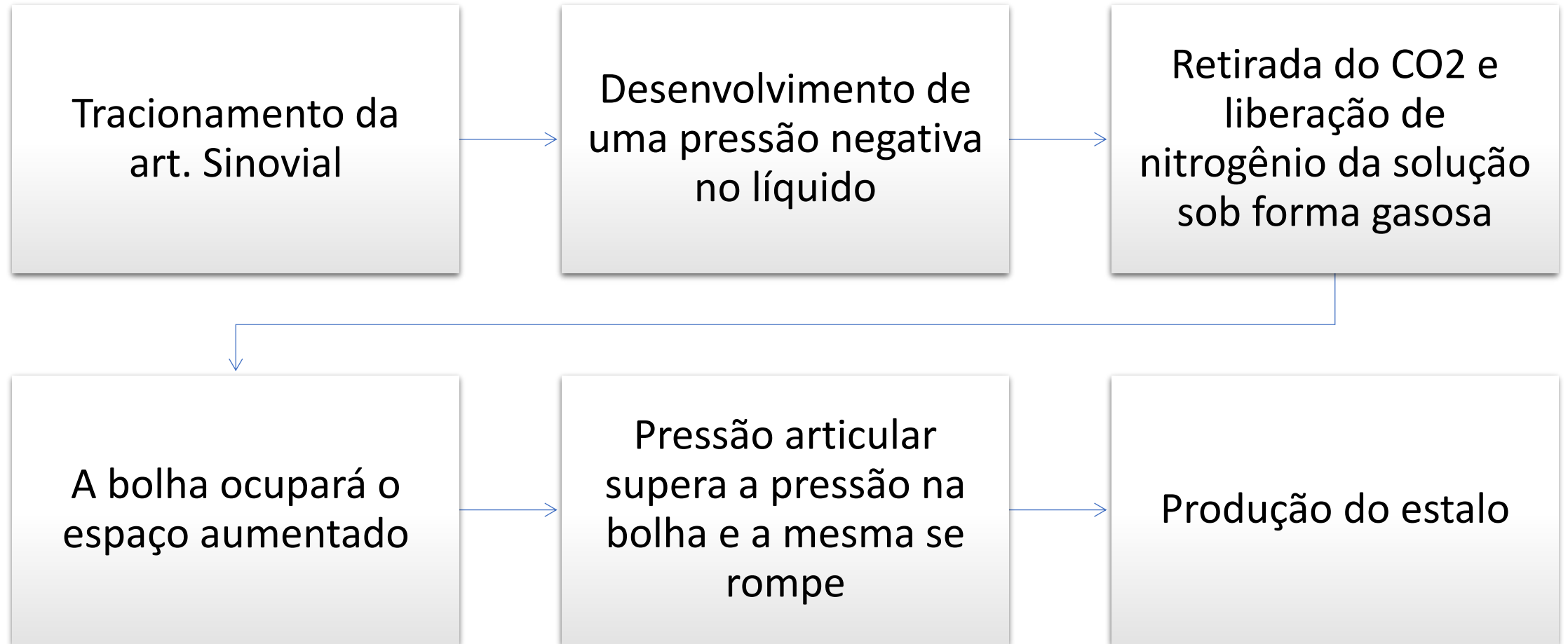
Excesso capsular no recesso axilar da prega inferior da cápsula da articulação glenoumeral.

MOBILIZAÇÃO x MANIPULAÇÃO

- Mobilização: “movimento passivo especializado da mão que pode ser executado com amplitudes variáveis a velocidades variáveis”.
- Manipulação: “movimento passivo especializado da mão, geralmente executado com uma pequena amplitude e uma velocidade elevada”.

Guide to Physical Therapist Practice

O Estouro Audível



O Estouro Audível

- Articulações normais comumente produzem um som audível;
- Articulações patológicas também produzem estalos (instabilidade articular; aspereza das bordas articulares; espessamento tecidual periarticular);
- O objetivo terapêutico de uma intervenção manual não deve ser um som audível, e sim o aumento na função, ou restauração do movimento normal, da articulação hipomóvel.

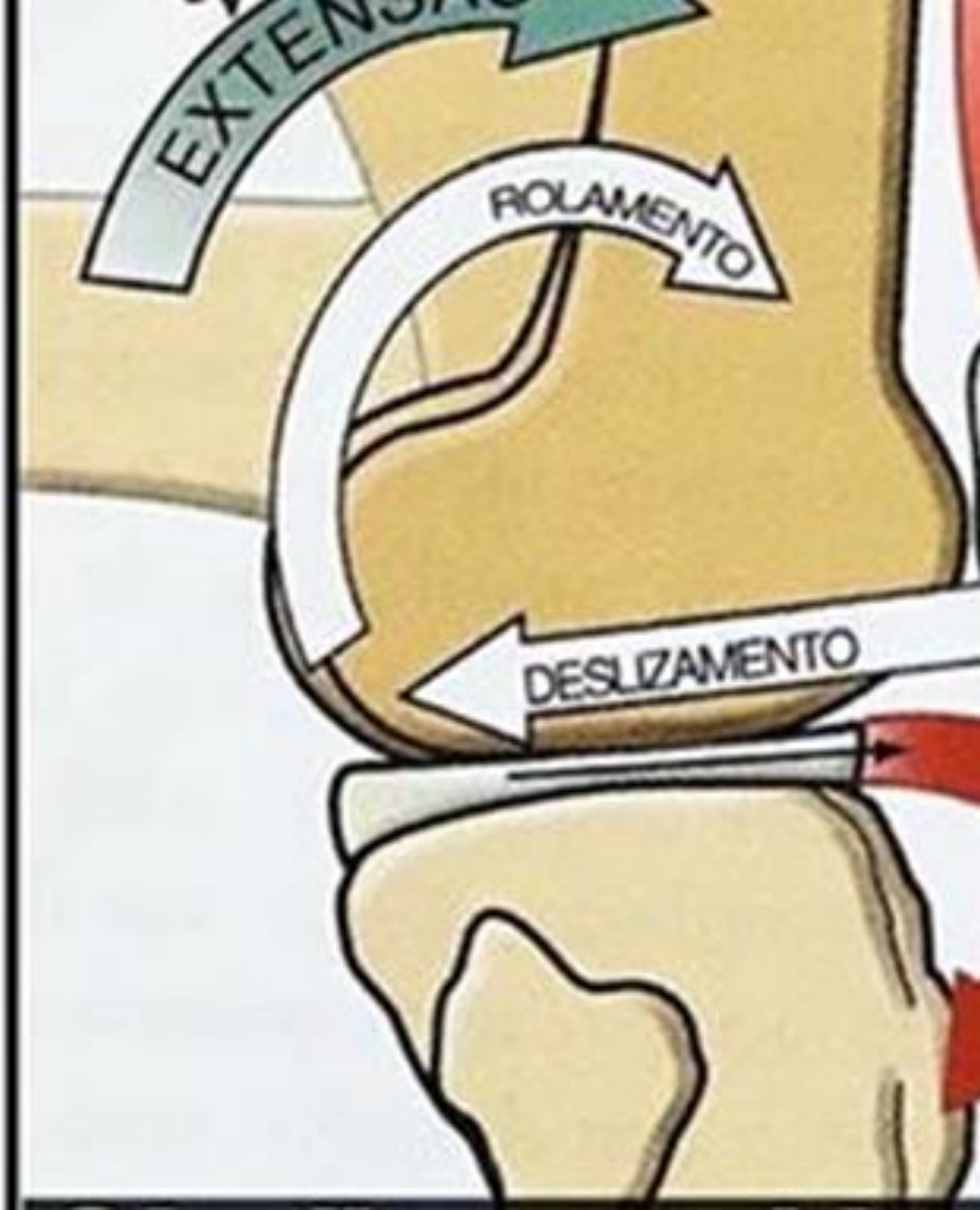
Mobilização Articular

- Terapia manual usada para modular a dor e tratar disfunções articulares que limitam a ADM;
- Conhecimento de anatomia, Artrocinemática, e patologia do sistema neuromioarticular;
- Seu emprego indiscriminado poderá por em risco as articulações do paciente;
- Quando indicada, é um meio seguro e eficiente de restaurar ou manter a mobilidade intra-articular, podendo ser usada para tratar a dor.



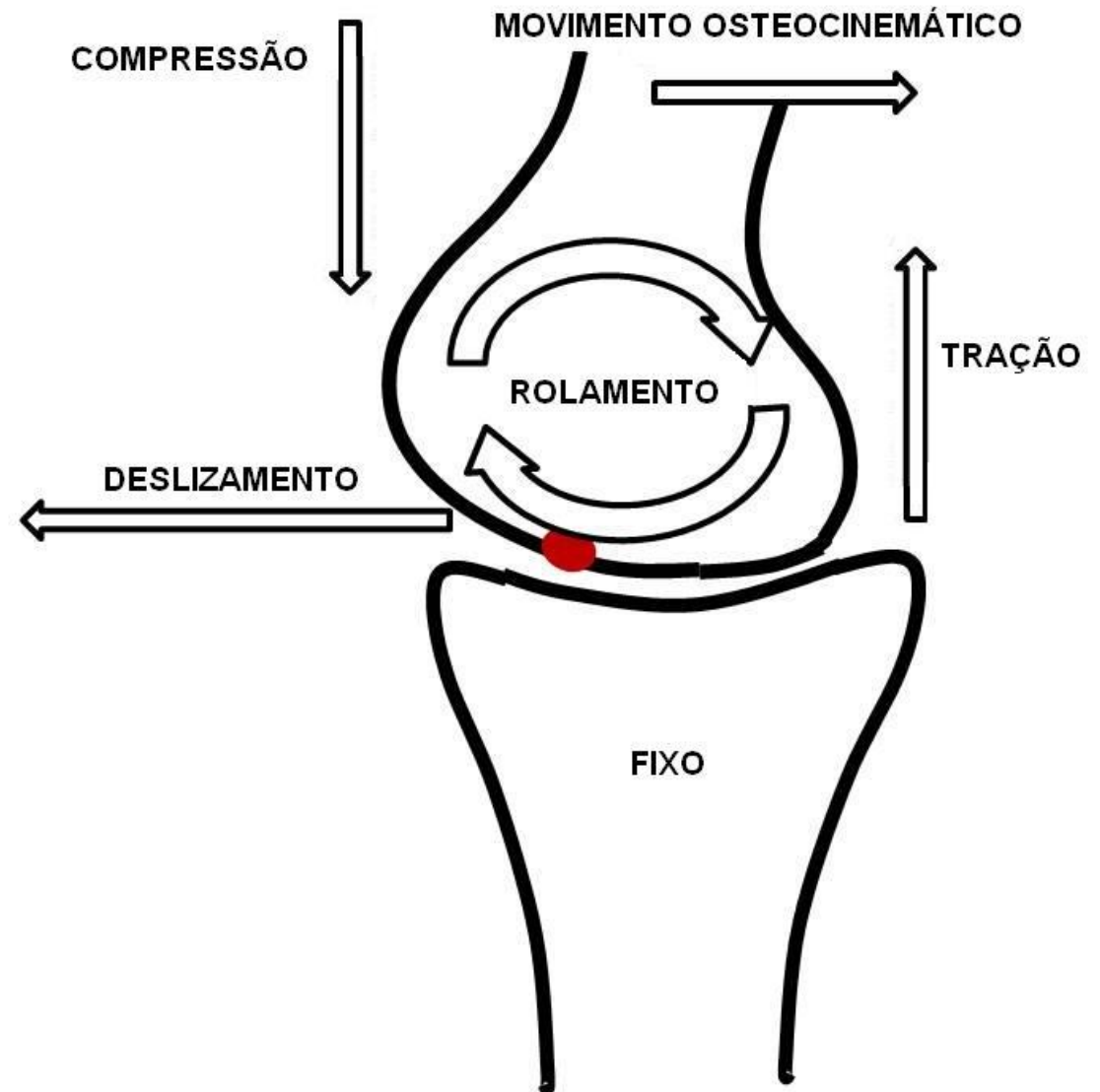
Mobilidade Articular: Conceitos Básicos

- Osteocinemática;
- Artrocinemática.



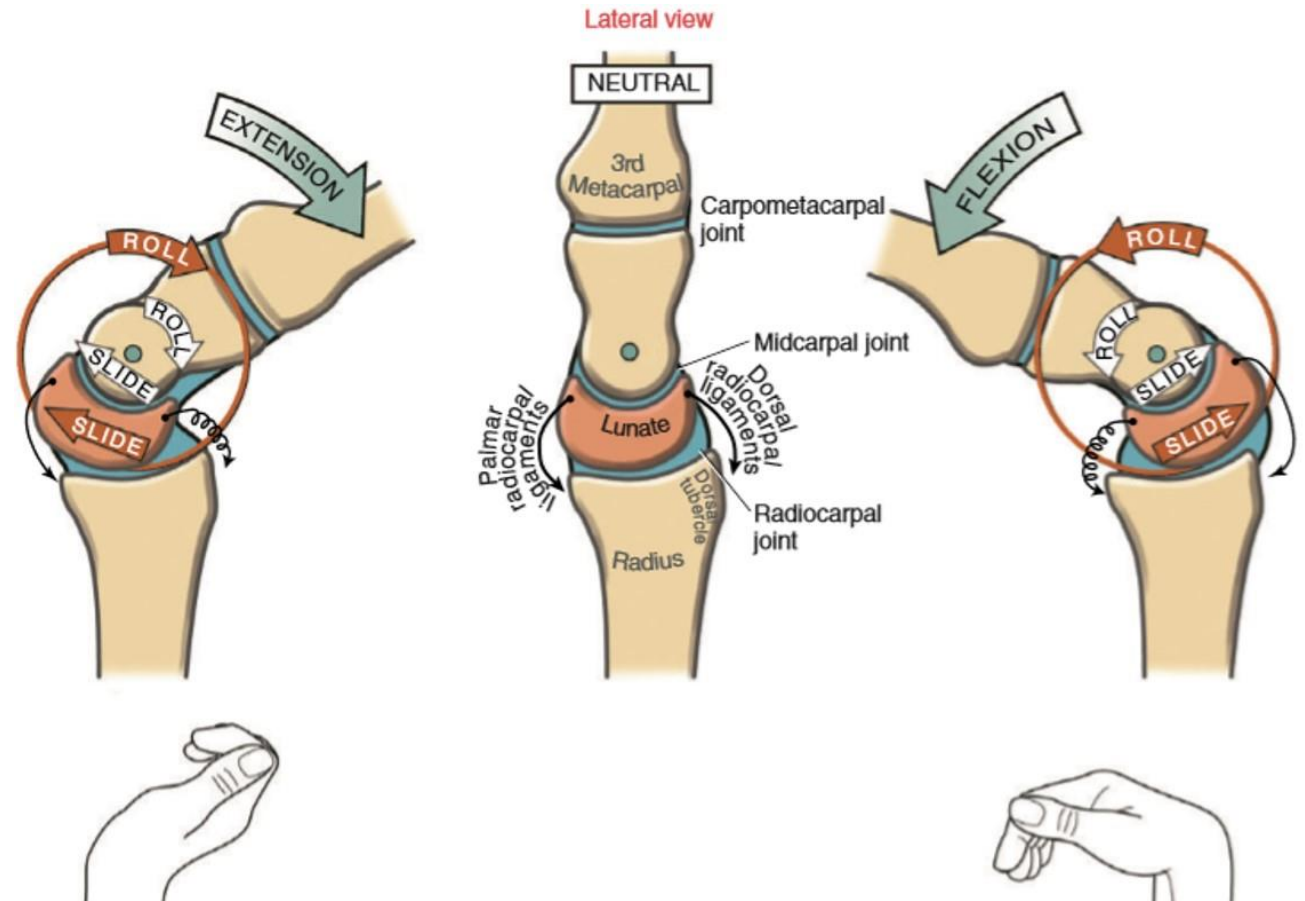
Atrocinemática

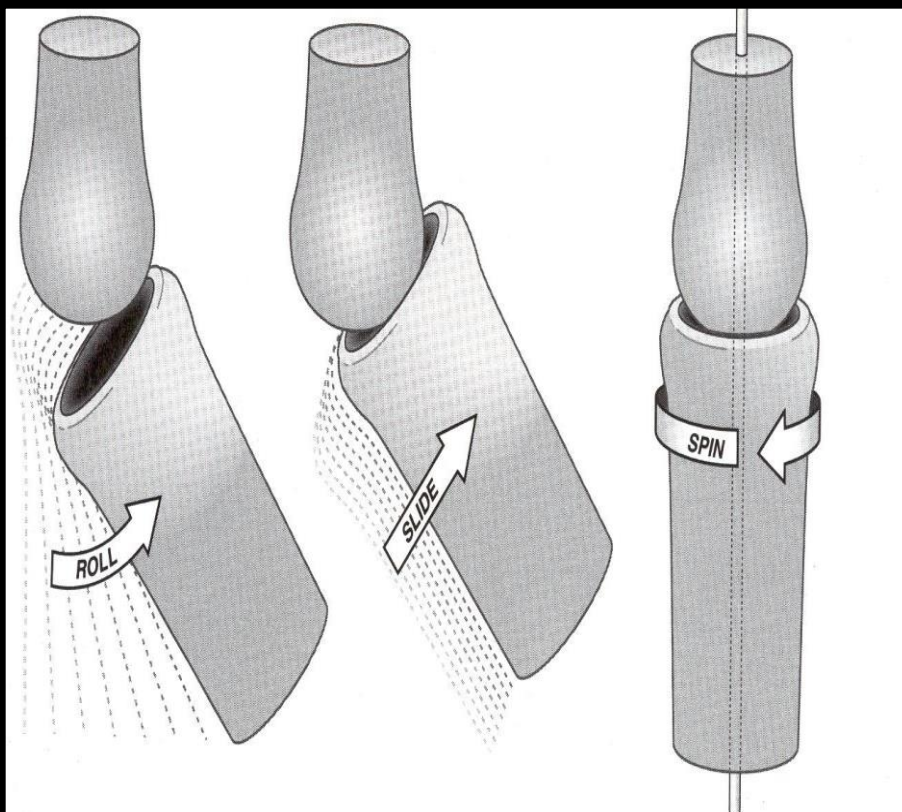
- Rolamento – Características:
 - superfícies incongruentes;
 - resulta em movimento angular do osso (oscilação);
 - é sempre na mesma direção que a oscilação.



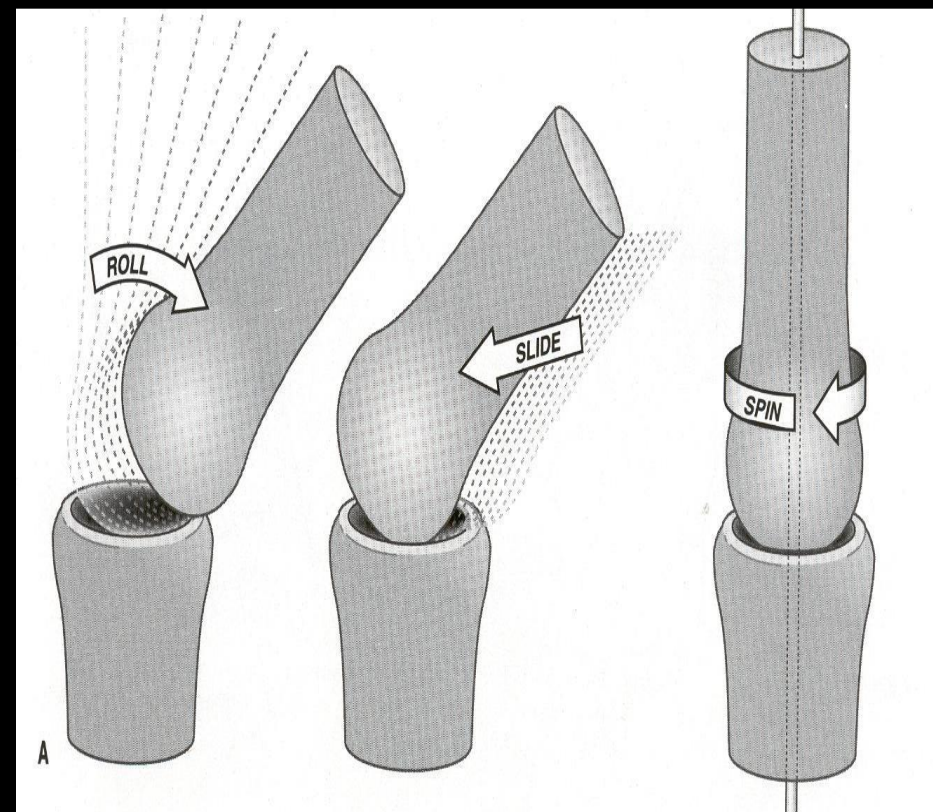
Artrocinemática

- Deslizamento – Características:
 - Para um deslizamento puro as superfícies devem ser congruentes, planas ou curvas;
 - A direção vai depender da superfície em movimento ser côncava ou convexa;
 - **Regra do Côncavo-Convexo.**





Côncavo – rolamento e
deslizamento
Mesmo sentido



Convexo – rolamento e
deslizamento
Em sentidos opostos



Efeitos da Mobilização Articular

- Resposta Tecidual:
 - Inflamações ou imobilizações articulares podem promover um espessamento da cápsula articular (maior produção de colágeno ou agrupamento de fibras individuais de colágeno);
 - A M.A. estressa a cápsula causando uma deformação plástica do colágeno;
 - Uma M.A. correta vai afrouxar e rearrumar as fibras de colágeno, rompendo as aderências, restaurando a mobilidade articular.

Efeitos da Mobilização Articular

- Base Neurológica:
- A mobilização em pequena escala pode ser eficaz no alívio da dor. Isso ocorre como consequência de 02 mecanismos:
 - A nutrição global da articulação é melhorada pelo movimento do líquido sinovial;
 - A mobilização ativa mecanorreceptores tipos I e II na cápsula articular, e a estimulação desses mecanorreceptores reduzem a dor.

Indicações, Contraindicações e Precauções

INDICAÇÕES

- Dor, Defesa Muscular e Espasmo;
- Hipomobilidade Articular Reversível;
- Limitação Progressiva (E.A.);
- Imobilidade Funcional.

CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES

- Hipermobilidade;
- Efusão Articular (edema);
- Inflamação;
- enfermidades malignas, doença óssea, fratura não consolidada, hipermobilidade, artroplastias, idosos.

Aplicação da M.A.

- Exame e avaliação:
 - Verificar se o paciente tem mobilidade limitada ou dolorosa;
 - Examinar e indicar os tecidos limitantes;
 - Determinar se o tratamento primará pelo alívio da dor ou para o alongamento da limitação articular.





Oscilação Graduada – Graus de Maitland

- Grau I: rítmicas de pequena amplitude (início da amp.)
- Grau II: rítmicas de larga amplitude (dentro da amp.)
- Grau III: rítmicas de larga amplitude (até o limite do movimento e forçadas dentro da resistência do tecido)
- Grau IV: rítmicas de pequena amplitude (limite da mobilidade disponível e forçadas dentro da resist. tec.)
- Grau V: manipulação brusca de pequena amplitude e alta velocidade (thrust)

I e II: tratar articulações limitadas pela dor

III e IV: usadas como manobras de alongamento

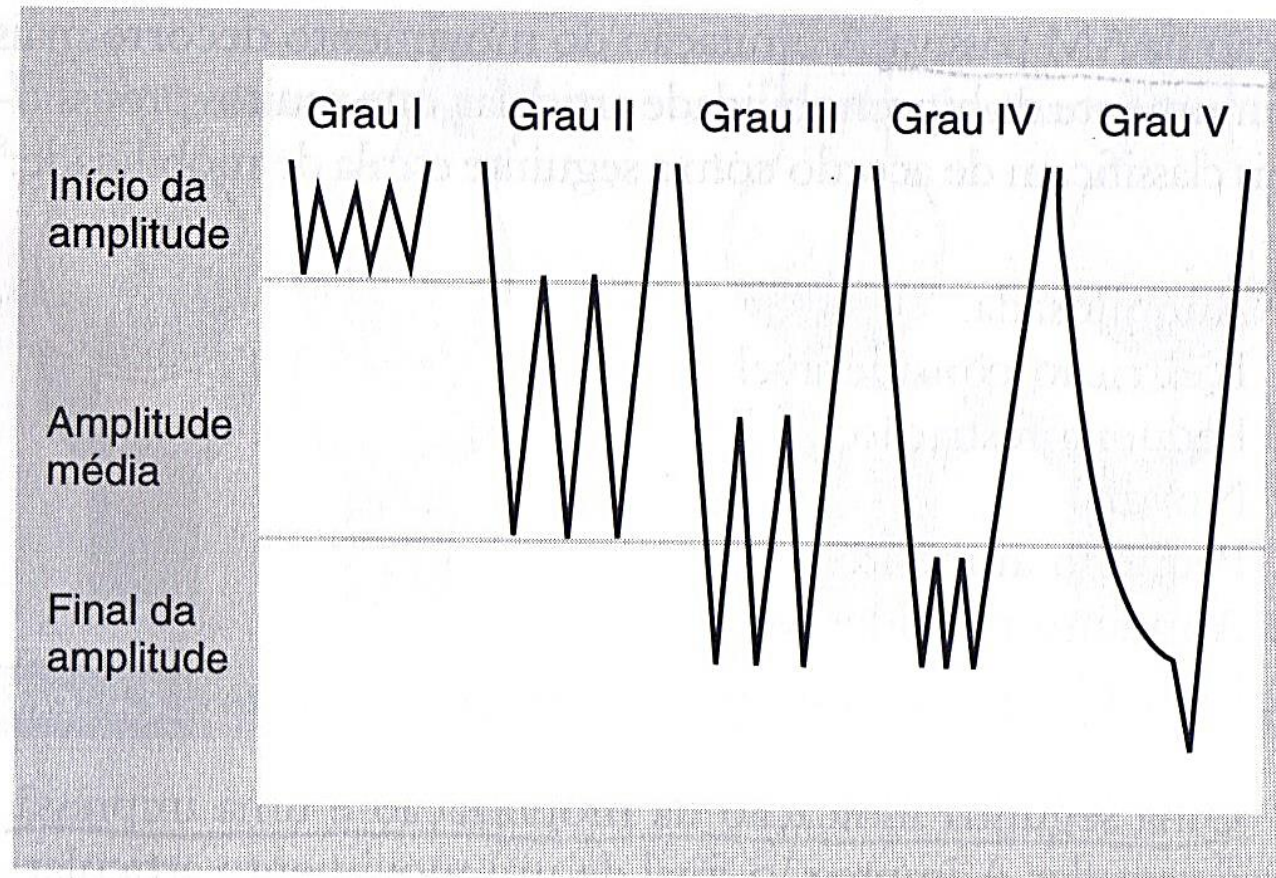


Fig. 4.5 Os cinco graus de mobilização de Maitland.

(Reimpresso com permissão de Saunders HD, Saunders R. Evaluation, treatment and prevention of mobilization disorders. Vol 1. Spine. Bloomington, MN: Educational Opportunities, 1993.)



Mobilização Intra-articular Translatória Sustentada – Graus de Kaltenborn

- Grau I (afrouxamento): aplicada separação de pequena amplitude onde nenhuma sobrecarga estiver localizada sobre a cápsula;
- Grau II (tensionamento): separação ou deslizamento suficiente para tensionar os tecidos em torno da articulação;
- Grau III (alongamento): separação ou deslizamento com amplitude suficiente para alongar a cápsula articular e estruturas Periarticulares

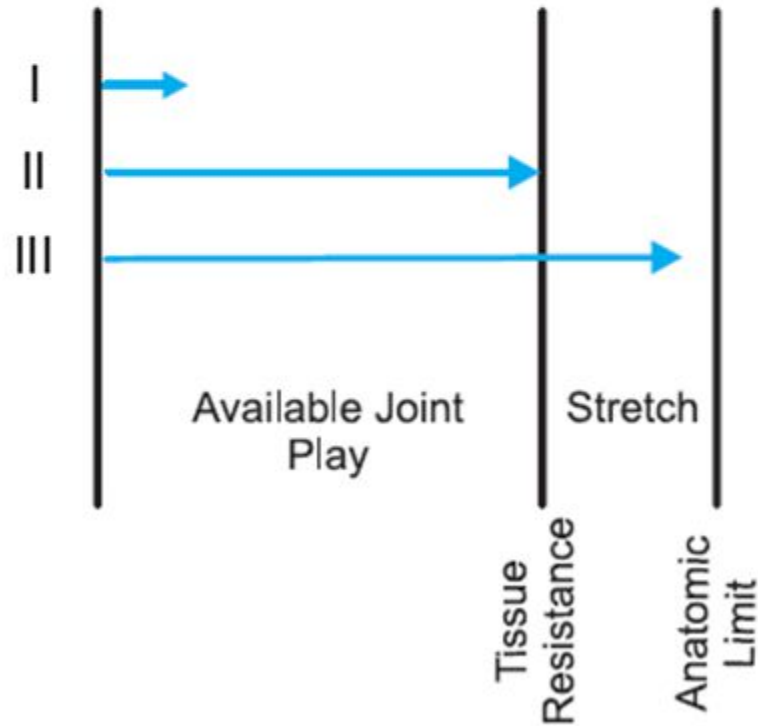
I: alívio da dor

II: determinar o nível de sensibilidade de uma articulação

III: alongar estruturas articulares, aumentar mobilidade intra-articular

Glide

- Sustained glide (Kaltenborn)

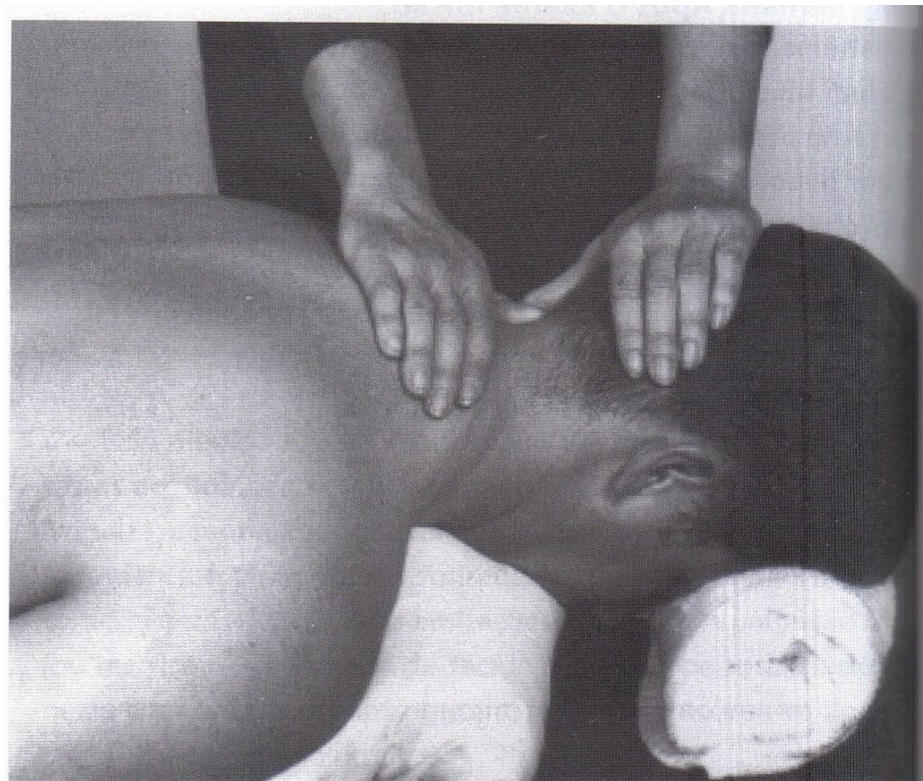


Prática de Mobilização Articular

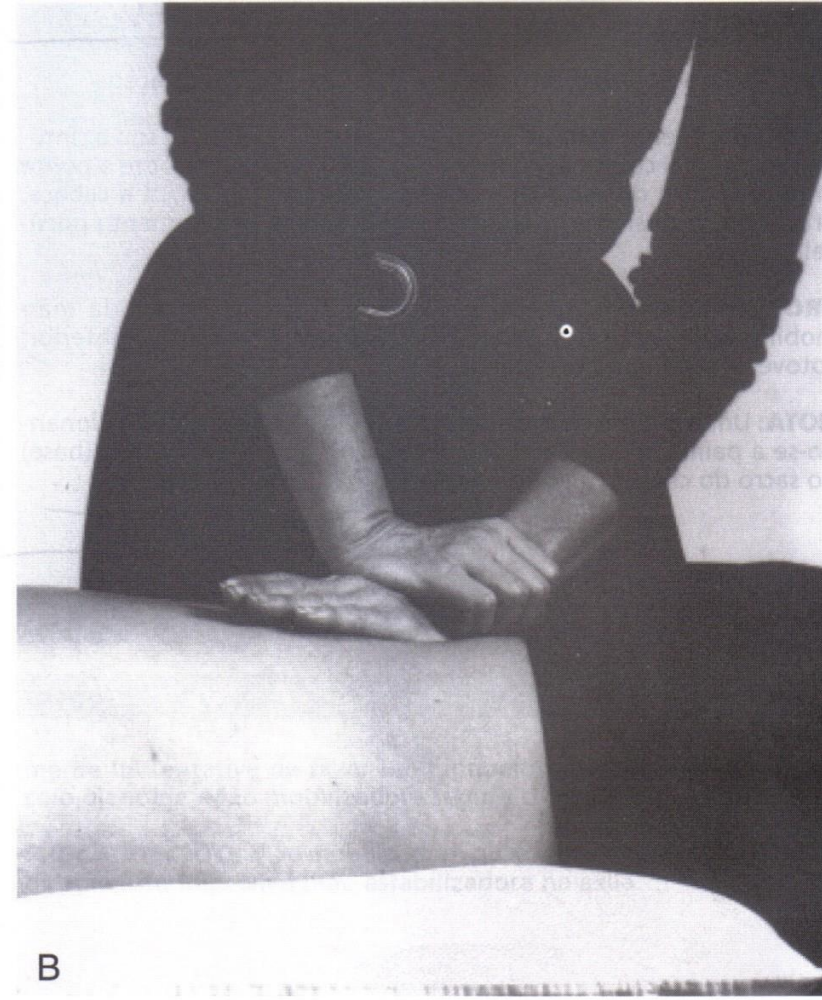
Deslizamento Cervical Pósterio-Anterior



Deslizamento Cervical Transverso



Deslizamento Lombar de Posterior para Anterior



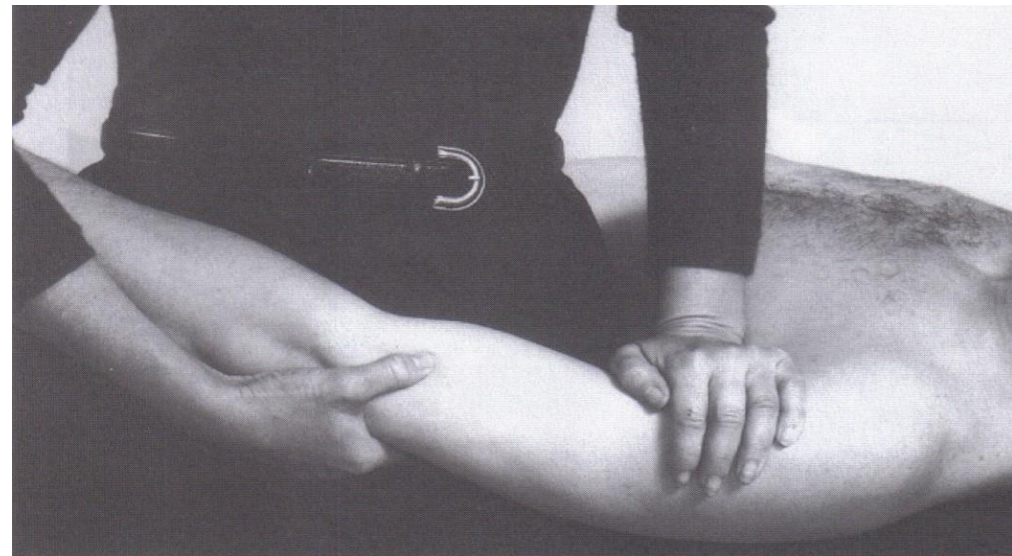
Deslizamento Lombar Transverso



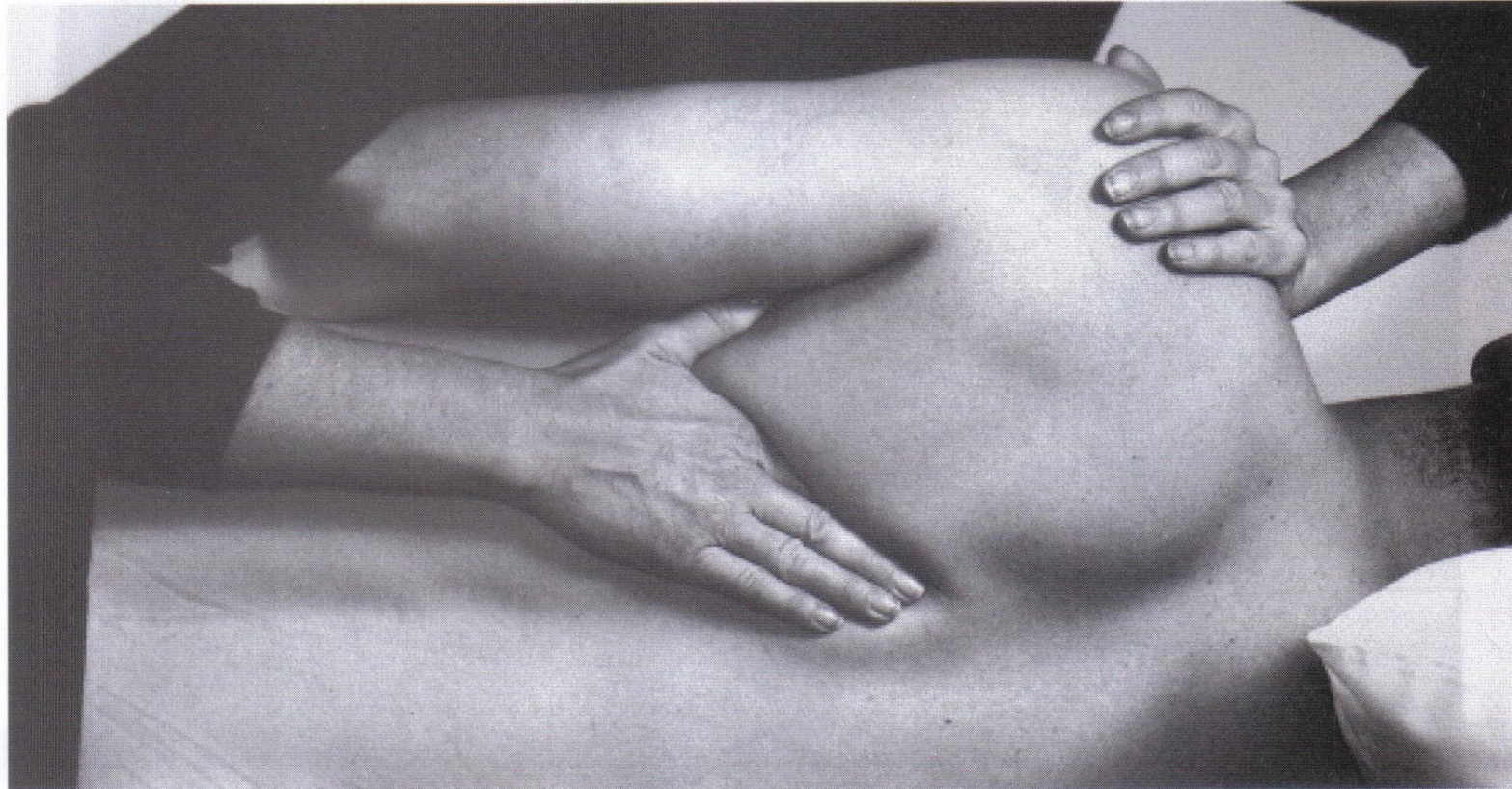
Deslizamento Inferior do Ombro



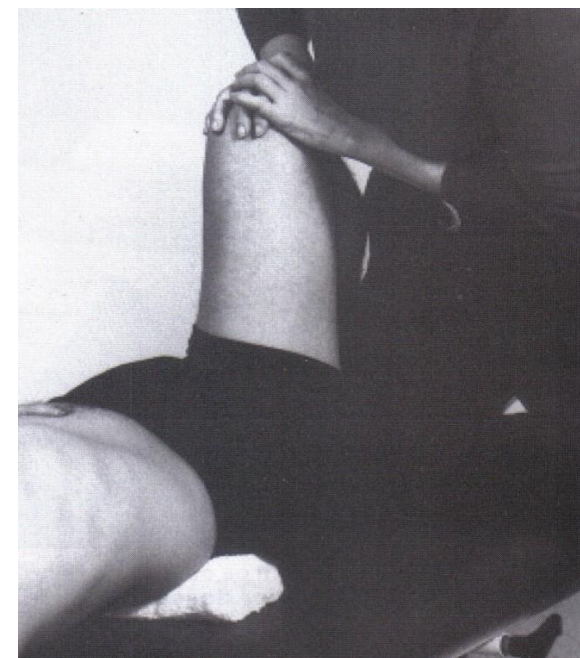
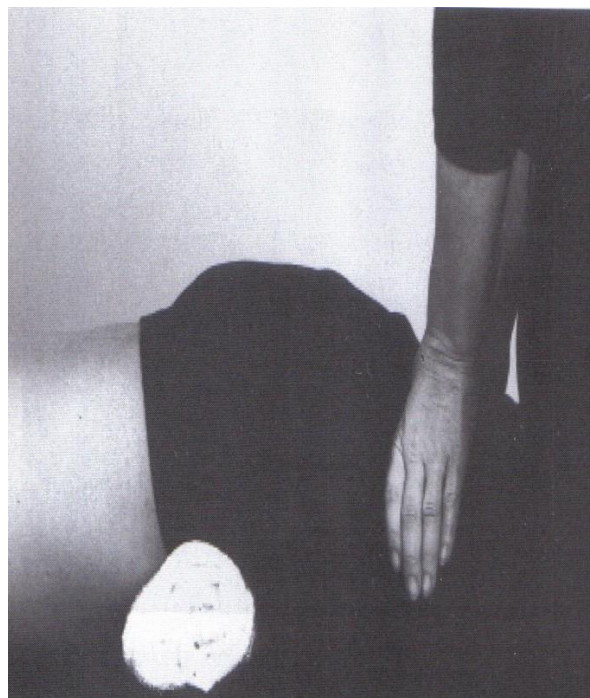
Mobilização Anterior e Posterior do Ombro



Mobilização Escapular



Deslizamento Lateral, Anterior e Posterior do Quadril



Deslizamento Anterior e Posterior do Joelho

